EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 95690
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-10-25 10:27:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: DORIS CIGALE OLIVARES POHL			RUN	: 6.425.867-2
F.Nac	: 02-03-1954	Edad	: 70 AÑOS, 7 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: PARC. 5 LA PRIMAVERA			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 99619362		
Fecha Ingreso	: 2024-10-21	Fecha Egreso	: 2024-10-25 10:27:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. E23.7-TRASTORNO DE LA GLANDULA HIPOFISIS, NO ESPECIFICADO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Hiponatremia recurrente en estudio
1.1 Patología hipofisiaria en estudio (Insuf suprarrenal cronica??? hipoaldostenorismo 2°???)
2) HTA
3) Adrenectomia derecha 2018
4) DLP

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. E23.7-TRASTORNO DE LA GLANDULA HIPOFISIS, NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente femenina de 70 años con antecedentes mórbidos HTA | Dislipidemia | Hiponatremia recurrente no especificadas desde 2018 sin estudios previos.
Acude por presentar desde hace 1 mes (14/09) aproxo. cefalea holocránea de leve intensidad asociado a náuseas, vómitos y evacuaciones líquidas, asociado a sensación de fatiga, cansancio y mareos persistentes, que limita la realización de actividades diarias.
Se manejó con tratamiento sintomático con sales de re-hidratación oral.
Evaluada en primera instancia por ORL donde descartan patología vestibular periférica. En vista de persistencia de síntomas, se realiza en extrasistema RMN cerebral sin contraste donde se informa presencia de quiste aracnoidal de fosa media derecha sin signos de complicación.
Es Evaluad por Neurologo durante su estancia en Urgencia quien observa en RM CEREBRAL aumento de volumen y señal de la hipófisis.
Examen Neurológico: - Mental: Vigil, Atenta. Orientada En T-E. Lenguaje: Nomina 5/5, Repite Frases > 3 Palabras 5/5, Comprende Órdenes Simples Y Complejas. Fluencia Conservada. Reconoce Derecha E Izquierda. Praxias Sin Alteraciones.
- Pc: Pupilas Medias, Normoreactivas A La Luz. Rfm Directo Y Consensual +/+. Cv Impresiona Conservado A La Amenaza. Moe Conjugados. Se Observa Leve Enlentencimiento En Abducción De Ojo Izquierdo, Sin Diplopía. Nistagmo Horizontal Correctivo En Mirada Horizontal A Izquierda. Simetría Facial Bilateral. Se Observa Ptosis Palpebral Superior Izquierda (Informada Por Familiar Como Constitucional Previo). Protruye Lengua En Línea Media.
- Motor: Fuerza M5 Global En 4 Ee. Pmp Negativo. Rem +++/+++. Rcp
- Sensitivo: Conservado
- Taxias: Conservadas. Maniobra De Utemberger + Con Lateralización A Izquierda.
- Signos Meníngeos Negativos.
Tomografía Computada De Cerebro: Quiste aracnoidal en fosa media izquierda sin significado patológico, hallazgo que no requiere control.
• LABORATORIOS: HB: 12.6/ HTO: 36.1/ LEUCOS: 5700/ PLT:205.000/ Glicemia: 102 mg/dl/ creatinina 0.6/ VFG: 98.83/ PCR: < 5,0/ NA: 127 mEq/l/ K: 5,3/ CL: 91/ TSH: 1.66/ T4: 0.83/ Cortisol: 13.18 | prolactina 16,99

• RMN cerebral sin contraste: quiste aracnoidal en fosa craneana media derecha sin signos de complicación. Aumento de volumen y señal hipofisiaria. Resto sin hallazgos patológicos.
Se decide ingreso apra compeltar estudio

Durante estadia se procede a completar estudio
Examenes de lab 24/10 -> TSH 2,53; T4L 0,72; cortisol 12,76; prolactina 11,39
TAC AP c/c 23/10 -> Sin halalzgos agudos, no se evidencia nodulos suprarrenales
Se solicita RNM de silla turca c/c, a la espera de relizacion

Paciente HDN estable, afebril, algo nauseosa durante interrogatorio, pero con buena toelrancia a VO previo a inicio de ayuno, diuresis registrada 800 cc, deposiciones (+)
Se informa q hora de RNM agendada para hoy fue cancelada

Ex fisico -> Vigil; CLOTE; mucosas rosadas, hidratadas, llene capilar < 2 segs
Cardiaco RR2T NAS
Pulmonar MP (+) SRA
Extremidades sin edema, sin signos de TVP

Actualmente en su dia N° 5 hospitalizada, en condiciones de continuar estudio de forma ambulatoria

PLAN DE MANEJO:

1) HDN: Estable, sin conflicto
2) Ventilatorio: Estable, sin conflicto
3) Endocrinologico: En vista de sospecha de hiperaldostenorismo 2°; se procedera a suspencion de LST; a la espera de toma de RNM el dia 30/10, se mantendra hospitalizacion via HODOm para seguimiento de paciente

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo Relativo
2. Regimen Hiposódico A Tolerancia
3. Metoclopramida 10 Mg c/8hrs VO por 7 dias
4. Paracetamol 500 mg, 2 comp c/8hrs VO por 7 dias
5. Atorvastatina 20 Mg VO al dia por 7 dias
6. RM Cerebral de Silla Turca c/c 30/10
7. Examenes de lab 28/10

DANIEL EDUARDO ACEVEDO PEREIRA
MEDICO TRATANTE
18431829-6

JEFE SERVICIO